HELP_Organi_P06 — Groupe A — Audits LOT 1 à 8 — 16 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 6 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

A-018 — Moyenne — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_B_V4_Argon_Partie_2_D2.3_a_D2.5__export_GoogleDoc.html › D2.5 › point 11.B R-CHOP (et D2.5 point 14 ; spécialités analogues en D2.7 et D2.8 : Cisplatin Ebewe®, Velbe®, Bleo-cell®, Detimedac®) ; constats L2-M22

Contexte : Le cours cite Oncovin® (autorisation inactive selon l'audit), Adriblastin®, Velbe®, Bleo-cell®, Detimedac® et Cisplatin Ebewe®, non vérifiés dans l'AIPS.

Question : Lesquelles des spécialités Oncovin®, Adriblastin®, Velbe®, Bleo-cell®, Detimedac® et Cisplatin Ebewe® sont autorisées et commercialisées en Suisse en 2026 ? Pour chaque DCI (vincristine, doxorubicine, vinblastine, bléomycine, dacarbazine, cisplatine), quelle spécialité suisse existe ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-019 — Moyenne — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_B_V4_Argon_Partie_4_D2.8_a_D2.10__export_GoogleDoc.html › D2.8 › point 11.D › Recherche 2026 ; constats L2-M25, L2-M26

Contexte : Le cours affirme que SWOG S1826 et GHSG HD21 ont montré une supériorité « sur l'ABVD et le BEACOPP » et interdit « à vie » une FiO2 > 30 % après bléomycine ; l'audit précise N-AVD vs BV-AVD et BrECADD vs eBEACOPP.

Question : Quelle est la recommandation ESMO (ou EHA/GHSG) la plus récente pour le lymphome de Hodgkin avancé de l'adulte (ABVD, BrECADD, N-AVD) et ces schémas sont-ils autorisés ou utilisés en Suisse ? Quelle source européenne encadre l'oxygénothérapie peropératoire après bléomycine (seuil de FiO2, durée du risque) ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-020 — Moyenne — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_B_V4_Argon_Partie_4_D2.8_a_D2.10__export_GoogleDoc.html › D2.9 › point 13 Points clés ; constats L2-M29, L2-M30, L2-L34

Contexte : Le cours fonde le diagnostic de sarcoïdose sur l'ATS 2020, attribue une VPP > 95 % au rapport CD4/CD8 > 3,5 et donne des seuils d'hypercalciurie (7,5 et 6,2 mmol/24 h) sans source.

Question : Quelle recommandation européenne (ERS 2021 pour le traitement, ERS/WASOG pour le diagnostic) définit les critères diagnostiques de la sarcoïdose, la place du lavage broncho-alvéolaire (performance du rapport CD4/CD8) et le bilan phosphocalcique (seuils d'hypercalciurie) ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-022 — Moyenne — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_B_V4_Argon_Partie_4_D2.8_a_D2.10__export_GoogleDoc.html › D2.10 › point 14 Pièges ; constats L2-M33, L2-L47, L2-L38

Contexte : Le cours affirme qu'un test rapide capillaire ne détecte que les anticorps, qualifie l'absence de transmission sous traitement de « zéro absolu, consensus suisse validé mondialement », et a perdu le chiffre de charge virale du pic de primo-infection.

Question : Quels tests de dépistage du VIH (laboratoire 4e génération, tests rapides, autotests) recommande l'OFSP en 2026, avec leur fenêtre diagnostique ? Quelle est la formulation actuelle de la Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles (CFIST,

ancien « Swiss statement » 2008) sur la non-transmission (seuil et durée de charge virale indétectable) ? Quel ordre de grandeur de virémie la littérature européenne donne-t-elle au pic de la primo-infection ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-023 — Moyenne — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_B_V4_Argon_Partie_2_D2.3_a_D2.5__export_GoogleDoc.html › D2.5 › point 7.2 Syndrome de lyse tumorale ; constats L2-L30

Contexte : Le cours décrit le syndrome de lyse tumorale avec une hyperkaliémie > 6,0 mmol/L sans attribuer les critères de Cairo-Bishop.

Question : Quels sont les critères biologiques et cliniques exacts du syndrome de lyse tumorale (Cairo-Bishop et mise à jour éventuelle), et quelle recommandation européenne la plus récente fixe sa prévention (hydratation, allopurinol, rasburicase) ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-024 — Moyenne — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_B_V4_Argon_Partie_3_D2.6_a_D2.7__export_GoogleDoc.html › D2.7 › point 11.D › Recherche 2026 ; constats L2-M24

Contexte : Le cours affirme un essai de phase III de mRNA-4157/V940 dans les carcinomes des voies aérodigestives supérieures, sans NCT ; l'audit n'en a trouvé aucun.

Question : Quels essais de mRNA-4157/V940 (intismeran autogène) existent en 2026 dans les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou (phase, NCT, statut) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-025 — Haute — LOT 3 · SSP G3

Emplacement : LOT_3_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › SSP G3 › 8. Critères ; constats L3-M09, L3-M10, L3-M25, L3-M28, L3-M37, L3-M39, L3-M59, L3-L41, L3-L64

Contexte : La V6 a supprimé les seuils de copeptine et définit la polyurie par « souvent » ; l'audit propose > 50 mL/kg/24 h, copeptine stimulée par NaCl 3 % ≤ 4,9 pmol/L (précision 96,5 %), basale ≥ 21,4 pmol/L, arginine 3,8 pmol/L (Fenske NEJM 2018, Refardt CARGOx). La V5 donne des seuils 2,6 et 2,6–4,9 pmol/L (déficit complet/partiel, « spécificité 100 % ») et des sensibilités/spécificités non retrouvées.

Question : Quelle recommandation européenne ou suisse la plus récente (ESE, Société suisse d'endocrinologie, revue de consensus bâloise) définit la polyurie, l'algorithme du syndrome polyurie-polydipsie et les seuils de copeptine (basale, après NaCl 3 %, après arginine, après glucagon), avec conditions de prélèvement, sensibilité et spécificité ? Quels seuils distinguent déficit complet et partiel en AVP ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-027 — Haute — LOT 3 · SSP G3

Emplacement : LOT_3_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › D3.2 › 11. Prise en charge › 11.B. Moyens ; constats L3-M12, L3-M31, L3-L17

Contexte : Le cours ne chiffre pas la vitesse de correction de l'hypernatrémie et fusionne les limites de l'hyponatrémie et de l'hypernatrémie ; l'audit propose ≤ 10 mmol/L/24 h (0,5 mmol/L/h) d'après la Revue Médicale Suisse 2023 et une revue 2024.

Question : Quelle source suisse ou européenne la plus récente fixe la vitesse maximale de correction de l'hypernatrémie aiguë (< 48 h) et chronique, le rythme de contrôle de la natrémie et le soluté de choix ? Les données récentes (études 2019–2025) remettent-elles en cause la limite de 10 mmol/L/24 h ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-030 — Haute — LOT 3 · SSP G3

Emplacement : LOT_3_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › D3.9 › 11. Prise en charge › 11.B. Moyens ; constats L3-M15, L3-M27

Contexte : La desmopressine est citée sans spécialité, forme, dose ni rythme ; l'audit propose Minirin® (comprimés, Melt, spray, injectable) et Nocutil® spray (10–40 µg/j).

Question : Quelles spécialités de desmopressine sont autorisées en Suisse pour le déficit en AVP (Minirin®, Minirin® Melt, Nocutil®, forme injectable) et quelles doses initiales, titrations, surveillances de la natrémie et mises en garde (hyponatrémie, sujet âgé) prévoit leur AIPS ? Indique

la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-037 — Haute — LOT 3 · SSP G3

Emplacement : LOT_3_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › D3.6 › 11. Prise en charge › 11.B. Moyens ; constats L3-M21, L3-M49, L3-M50

Contexte : La V6 ne cite aucun médicament ni seuil pour l'hyponatrémie hypervolémique ; l'audit propose spironolactone 100–400 mg/j ± furosémide 40–160 mg/j, restriction hydrique si natrémie < 125 mmol/L, sel 80–120 mmol/j (EASL 2018) et un usage exceptionnel du tolvaptan.

Question : Quelle version la plus récente des recommandations EASL sur la cirrhose décompensée (2018 ou ultérieure) et ESC sur l'insuffisance cardiaque fixe la conduite de l'hyponatrémie hypervolémique : seuil de restriction hydrique, doses de diurétiques, apport sodé, place du tolvaptan (Samsca® : autorisation et mises en garde suisses) ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-032 — Moyenne — LOT 3 · SSP G3

Emplacement : LOT_3_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › D3.8 › 2. Épidémiologie ; constats L3-M17, L3-M20, L3-M24, L3-L61, L3-M22

Contexte : Le cours donne « 60 % des cas », « ~500 000 personnes diabétiques », « 4 cas pour 100 000 » et des badges de 60 % à 0,7 % sans source ; la V6 met « donnée non trouvée » partout et D3.8 contient une phrase sur la fatigue issue d'un autre lot. L'audit cite Christ-Crain 2019 (déficit en AVP ≈ 1/25 000) et l'Obsan.

Question : Quelles données suisses (Obsan, OFS, Enquête suisse sur la santé) chiffrent la prévalence du diabète sucré et de la maladie rénale chronique, et quelles données européennes chiffrent la prévalence du déficit en AVP, de la polydipsie primaire et de l'hyperparathyroïdie primaire ? Donne année, population et URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-033 — Moyenne — LOT 3 · SSP G3

Emplacement : LOT_3_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste__export_GoogleDoc.html › Bloc 2 › D3.1 (source) ; même problème en D3.7 (« source : Endocrine Society ») et en Partie 3 › D3.7 › 11.B ; constats L3-M23

Contexte : L'Appel A fonde le diabète sur l'ADA et l'hypercalcémie sur l'Endocrine Society.

Question : Quelles recommandations suisses (SSED/SGED, Swiss Recommendations for type 2 diabetes) et européennes (EASD, ESE, workshop international 2022 sur l'hyperparathyroïdie primaire) servent de référence en 2026 pour le diagnostic du diabète (seuils de glycémie et d'HbA1c) et de l'hyperparathyroïdie primaire ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-034 — Moyenne — LOT 3 · SSP G3

Emplacement :
LOT_3_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_D3.3_a_D3.5__export_GoogleDoc.html › D3.4 › 11. Prise en charge › D- Pronostic et Recherche 2026 ; constats L3-M34, L3-L32, L3-M38, L3-L34

Contexte : La V5 attribue à un essai bâlois l'efficacité du sémaglutide (Ozempic®/Wegovy®) dans la polydipsie primaire « réfractaire » ; l'audit a vérifié Winzeler JCI 2021 (dulaglutide, 34 patients, 3 semaines). Le cours affirme aussi l'exclusivité de la clozapine sans source.

Question : Quelles études (auteur, année, NCT) évaluent en 2026 les agonistes du GLP-1 (dulaglutide, sémaglutide) et la clozapine dans la polydipsie primaire, et une recommandation européenne leur donne-t-elle une place ? Quel est leur statut d'indication en Suisse ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-035 — Moyenne — LOT 3 · SSP G3

Emplacement :
LOT_3_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_D3.3_a_D3.5__export_GoogleDoc.html › D3.3 › 11. Prise en charge › B- Moyens (atteintes systémiques) ; constats L3-M42, L3-L42, L3-M43

Contexte : Le cours présente le rituximab comme traitement du Sjögren sans signaler l'usage hors étiquette et affirme que des essais « valident » l'ianalumab, le dazodalibep et le nipocalimab.

Question : Quelle place la recommandation EULAR la plus récente (2020 ou mise à jour) donne-t-elle au rituximab dans le syndrome de Sjögren, quel est son statut Swissmedic dans cette indication

(art. 71a OAMal) et quels essais de phase III (NCT, résultats) concernent l'ianalumab, le dazodalibep et le nipocalimab ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-036 — Moyenne — LOT 3 · SSP G3

Emplacement :
LOT_3_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_D3.3_a_D3.5__export_GoogleDoc.html › D3.5 › point 11 › B- Moyens non médicamenteux ; constats L3-L37, L3-M52, L3-L36

Contexte : Le cours reprend un délai d'arrêt périopératoire des gliflozines de 3–4 jours (FDA), affirme sans source un effet correcteur des gliflozines sur l'hyponatrémie de l'IC et un facteur « divise par trois » en D3.5 point 12.

Question : Que disent les AIPS suisses de Jardiance® et Forxiga® (mises en garde) et la recommandation suisse ou européenne la plus récente sur l'arrêt des inhibiteurs SGLT2 avant chirurgie ou en situation aiguë (délai, reprise, cétonémie) ? Existe-t-il des données publiées sur l'effet des gliflozines sur la natrémie ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-038 — Moyenne — LOT 3 · SSP G3

Emplacement :
LOT_3_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_D3.8_a_D3.10__export_GoogleDoc.html › D3.9 › 11. Prise en charge › D- Pronostic et Recherche 2026 ; constats L3-M57

Contexte : La V5 date de façon erronée la démonstration du déficit en ocytocine dans le déficit en AVP ; l'audit cite Atila, Lancet Diabetes Endocrinol 2023, et un essai de substitution « planifié ».

Question : Quels essais de substitution par ocytocine dans le déficit en AVP (équipe de Bâle, Christ-Crain) sont enregistrés ou publiés en 2026 (NCT, phase, résultats) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P06 — 16 questions : A-018, A-019, A-020, A-022, A-023, A-024, A-025, A-027, A-030, A-037, A-032, A-033, A-034, A-035, A-036, A-038